This document was generated using a trial version of DevExpress libraries and can only be used for evaluation purposes.
Please purchase a license to continue use of DevExpress product libraries (v24.1.6.0)

Servizio Riabilitazione AISM Liguria

Cartella foniatrica prima visita

AISM_F014

COGNOME: TESTPZC NOME: TESTPZ

Indirizzo: VIA DI TEST 100/1,123 CAP: 16000 Città: GENOVA

Data di nascita: 23/06/1954 Sesso: M Luogo di nascita: GENOVA,ITALIA

Codice fiscale: AAAAAA00A00A999A ASLASL 3 GENOVESE

Diagnosi principale: 340 - 046 - Sclerosi multipla

Motivo della visita: * **Test FSE**

ANAMNESI SPECIALISTICA:* **Test FSE**

ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA* **Test FSE**

Terapia in atto e modalità di somministrazione: * **Test FSE**

Valutazione morfologico e funzionale delle strutture oro-faringo-laringee : * **Test FSE**

Quadro clinico specialistico * **Test FSE**

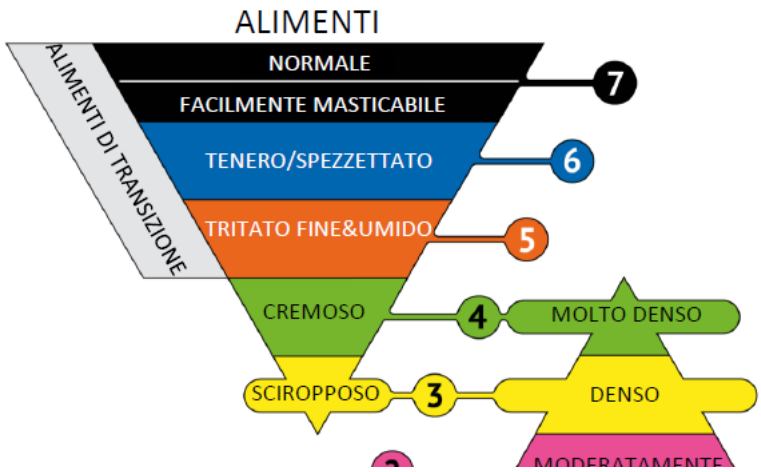
PRESCRIZIONI:

Modalità di alimentazione consigliata: * **Test FSE**

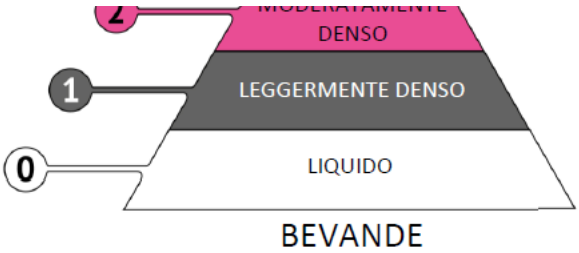
PROGETTO RIABILITATIVO:* **AMB**

PROBLEMI IDENTIFICATI:* **Test FSE**

OBIETTIVI:* **Test FSE**



This document was generated using a trial version of DevExpress libraries and can only be used for evaluation purposes.
Please purchase a license to continue use of DevExpress product libraries (v24.1.6.0)



Esempi di: DOPPIE CONSISTENZE (es. Minestrina in brodo, frutta molto matura, zuppe di pane o fette biscottate…), CIBI SECCHI (es. pan biscotto), STOPPOSI (es. petto di pollo ai ferri, allo spiedo), FIBROSI (es. verdure filacciose, prosciutto crudo, bresaola…), FRUTTA SECCA, LEGUMI, RISO AL DENTE, ALCOLICI

Si raccomanda di:

- mangiare in posizione seduta, con avambracci comodamente appoggiati e, salvo diversa indicazione con capo in asse;
- durante l'alimentazione lo stato di attenzione del paziente deve essere adeguato; interrompere l'alimentazione ai primi segni di stanchezza;
- procedere lentamente, con piccole quantità alla volta e solo se il boccone precedente è stato deglutito;
- non far parlare il paziente durante il pasto, se non dopo aver fatto detergere la gola con qualche colpo di tosse e aver fatto deglutire a vuoto;
- ogni 2-3 deglutizioni eseguire qualche colpo di tosse e deglutire a vuoto;
- se il paziente può assumere liquidi prima di farlo bere accertarsi che in bocca non siano presenti residui di cibo e far eliminare i residui in faringe secondo la modalità sopra descritta;
- non far distrarre il paziente durante il pasto (per esempio evitare di far guardare la televisione, leggere ecc);
- per almeno quindici minuti dopo il pasto, il paziente deve rimanere seduto ed in seguito è indispensabile provvedere all'igiene orale, per prevenire tra l'altro l'aspirazione di particelle di cibo che possono rimanere in bocca.

** Gli esempi sono stati integrati dal Gruppo di Lavoro del PDTA Disfagia Piemonte Simonelli M. et al. Gruppo Italiano di Studio Della Disfagia GISD. Proposta della Commissione Nazionale GISD sulla Terminologia per le consistenze.*

Confermo che il PRI è stato con me condiviso, compreso e accettato

Firma paziente o suo delegato

_____

Data: 09/12/2025

Firma Medico

_____

_____ GSAdmin GSAdmin

_____

_____